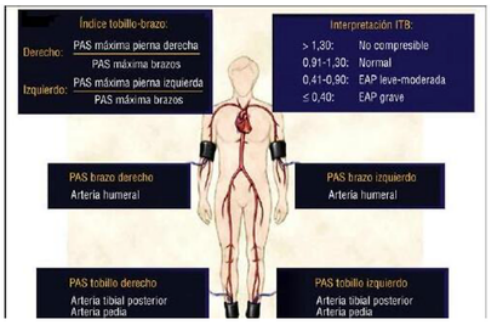
CIRUGÍA VASCULAR
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

DR. GERARDO VICTORIA

DEFINICIÓN Y FACTORES DE RIESGO

- EAP: obstrucción del flujo sanguíneo en arterias, excluyendo coronarias y cerebrales; índice tobillo-brazo (ITB) en reposo <0.9.
- Causa principal: aterosclerosis; afecta el doble a hombres que a mujeres, y aumenta con la edad.
- Factores: locales (protrombóticos, patrones de flujo), sistémicos (HTA, hiperlipidemia, hipercoagulabilidad), obesidad, diabetes, genética y estilo de vida (tabaquismo, sedentarismo).



HISTORIA NATURAL Y PRONÓSTICO

- La mitad de los pacientes con EAP son asintomáticos; síntomas: claudicación intermitente, dolor de reposo, ulceración o gangrena.
- Morbilidad de la extremidad: claudicación estable 70-80%, empeora 10-20%, isquemia crítica 1-2%.
- Morbimortalidad cardiovascular: eventos CV no fatales 15-30% (75% por causas CV); mortalidad 15-30%.

CLASIFICACIÓN CLÍNICA

CLASIFICACIÓN DE FONTAINE		CLASIFICACIÓN DE RUTHERFORD		
Clase I	Asintomático, pulsos disminuídos, ITB < 0.9	GRADO 0	CATEGORÍA 0	Asintomático
Clase II	Claudicación intermitente	GRADO I	CATEGORÍA 1	Claudicación leve
IIa	Claudicación leve	GRADO I	CATEGORÍA 2	Claudicación moderada
IIb	Claudicación Moderada a severa	GRADO I	CATEGORÍA 3	Claudicación severa
Clase III	Dolor de reposo diario	GRADO II	CATEGORÍA 4	Dolor isquémico de reposo
Clase IV	Necrosis tisular focal	GRADO III	CATEGORÍA 5	Pérdida tisular menor
		GRADO IV	CATEGORÍA 6	Pérdida tisular mayor

EXAMEN FÍSICO VASCULAR

- PA en ambos brazos, auscultación de carótidas, abdomen y fosas ilíacas, palpación de pulsos (humeral, radial, femoral, poplíteo, tibial posterior, pedio).
- Intensidad del pulso: 0=ausente, 1=disminuido, 2=normal, 3=saltón.
- Test de Allen si se requiere evaluar perfusión de la mano; inspección de pies (color, temperatura, integridad de la piel).

TAMIZAJE E ÍNDICE TOBILLO-BRAZO

- Tamizar a: >70 años, 50-69 fumadores o diabéticos, síntomas con ejercicio, dolor isquémico de reposo, pulsos anormales, enfermedad renal/coronaria/carótida.
- Interpretación del ITB: >1.30 no compresible; 0.91-1.30 normal; 0.41-0.90 EAP leve-moderada; ≤0.40 EAP grave.

TRATAMIENTO

- No farmacológico: dejar de fumar, ejercicio supervisado (30-45 min, 3 veces/semana, mínimo 12 semanas), control de HTA/diabetes/lípidos.
- Farmacológico: antiagregantes (ASA 75-325mg o clopidogrel 75mg), estatinas (meta LDL<100), cilostazol 100mg c/12h (contraindicado en ICC).
- Terapia invasiva: revascularización endovascular o quirúrgica.